

La Famiglia

I Tempi della Vita · Sessione 05 · A.A. 2025–2026

Questa lezione è un po' come studiare l'ecosistema di una foresta: la famiglia non è un singolo albero, ma un intreccio di radici, rami e specie diverse che si evolvono nel tempo. Capire come funziona — biologicamente, psicologicamente, socialmente — è fondamentale per chi fa lavoro sociale. Niente grafici d'esame vuoti: solo concetti che userai davvero sul campo.

Che cos'è la famiglia? Definizioni a confronto

La domanda sembra banale, ma non lo è. Il punto di partenza della lezione è proprio questo: **non esiste una definizione universale di famiglia**, e capire perché è già metà del lavoro.

Lévi-Strauss identificava tre pilastri che legano famiglia e società: - la **proibizione dell'incesto** - una **forma riconosciuta di unione** - la **divisione sessuale dei compiti**

Ma oggi queste categorie scricchiolano. La coppia, il genitore, la famiglia stessa hanno assunto forme che sfidano ogni schema classico.

Fonte	Definizione
Scabini & Cigoli (2000)	Organizzazione che lega differenze fondamentali: generi, generazioni e stirpi — con la generatività come progetto centrale
Vegetti Finzi & Celli (2011)	Due persone legate da vincolo sociale, che condividono casa, figli e impegni comuni
Dizionario Devoto Oli	

Fonte	Definizione
	Nucleo sociale di due o più individui che vivono insieme, legati da matrimonio, parentela o affinità (<i>dal lat. "famulus" = servo</i>)
Delvecchio (2013)	Sistema complesso derivante da storie, esperienze e relazioni — non riducibile alla somma dei suoi membri
Fruggeri (2005)	Non più un'istituzione, ma un' unione di affetti
Colozzi (2009)	Il topos delle certezze — il luogo sicuro dove rifugiarsi in un mondo esterno frammentato

La svolta concettuale chiave: i sociologi ormai parlano di **"famiglie" al plurale**, non più di "famiglia". Un singolo individuo può attraversare più forme familiari nel corso della vita.

Tipologie di organizzazioni familiari (Alvaro et al., 2007)

Nucleare · Monoparentale · Ricomposta · Omo-genitoriale · D'affido · Adottiva · Da procreazione assistita · Di genitori separati · Unipersonale · LAT (*Living Apart Together*) · DINKS (*Double Income, No Kids*)

Sguardo antropologico: cosa significa davvero "genitore"?

Prima di parlare di crisi della genitorialità, l'antropologia ci offre uno strumento prezioso per decostruire il concetto.

Esther Goody (1976, 1999) ha scomposto la genitorialità in **cinque funzioni**, che nelle società occidentali tendono a concentrarsi sulle stesse persone, ma in altre culture (africane, studiate da Goody) vengono distribuite tra più adulti:

1. Concepire e mettere al mondo
2. **Nutrire**
3. **Educare**

4. Dare un'identità alla nascita
5. Garantire l'accesso allo statuto di adulto

Pensa alle radici di una pianta: nella nostra cultura tendiamo a volerle tutte concentrate nello stesso vaso (padre + madre biologici). In altre culture, ogni radice può nutrirsi da un substrato diverso, e la pianta cresce comunque.

Dissociazione della genitorialità

Oggi si distingue tra: - **Genitorialità biologica** — chi concepisce - **Genitorialità istituzionale/giuridica** — chi ha il riconoscimento legale - **Genitorialità domestica** — chi si occupa della cura quotidiana

Il sistema occidentale rimane ancorato a tre principi nella filiazione: - **Bilateralità** (due genitori riconosciuti) - **Ideologia del sangue** (legame biologico come primario) - **Esclusività** (un solo set di genitori "veri")

Questo crea tensioni evidenti con le nuove forme di plurigenitorialità (famiglie adottive, ricomposte, omo-genitoriali, ecc.).

Evoluzione storica della famiglia occidentale

La famiglia nucleare si è consolidata come modello tra il XVI e il XVII secolo. Tre periodi principali:

Famiglia tradizionale (XVI–XVIII sec.)

- Famiglia dell'*Ancien Régime*: il **padre** esercita autorità assoluta
- Donne e figli sottomessi alla sua volontà
- L'amore romantico era percepito come **pericoloso** per le strategie familiari (il matrimonio unisce stirpi, non individui)

Famiglia moderna (fine XVIII – XX sec.)

- Il Padre-tiranno cede il posto al padre affettuoso; il **bambino viene posto al centro**

- Attenzione affettiva ed educativa verso i bambini
- Ma nel 1803 il **codice civile napoleonico ristabilisce la potenza paterna**
- Rigida divisione dei ruoli; inferiorità giuridica della moglie

Famiglia contemporanea / post-moderna (fine anni '60 in avanti)

Il punto d'inflessione demografico è il **1965**: calano fecondità, nuzialità, aumentano divorzi e matrimoni tardivi.

Cambiamenti strutturali: - Nuovo ruolo della **donna** (lavoratrice, autonoma, portavoce di nuovi diritti) - Ridimensionamento del modello **patriarcale** - Valorizzazione della **soggettività individuale** e dell'autorealizzazione - Coniugalità "privatizzata": il matrimonio come scelta personale, non un obbligo sociale - **Precarizzazione dell'unione** di coppia

Cambiamenti culturali nella transizione alla genitorialità

(Scabini & Cigoli, 2000)

Quattro trasformazioni fondamentali che caratterizzano la genitorialità contemporanea:

1. Si diventa genitori più tardi nella vita L'età media al primo figlio si è spostata significativamente in avanti in tutto l'Occidente.

2. Avere figli è diventato sempre più raro Fenomeno noto come "**seconda transizione demografica**" (Lesthaeghe & Van de Kaa, 1986): calo strutturale della fecondità, disallineamento tra tassi di natalità e mortalità. In Svizzera il tasso di fertilità è tra i più bassi d'Europa.

Principali motivazioni per la scelta di non avere figli (De Pierrepont & Lévy, 2017): - Percezione negativa di bambini e gravidanza - Assenza di desiderio genitoriale - Rifiuto dei vincoli e dei ruoli legati alla genitorialità - Motivazioni altruistiche

(preoccupazioni etiche/ambientali) - Valori post-moderni: soddisfazione di bisogni "postmaterialisti"

3. La nascita è sempre più un evento scelto Si passa dalla nascita come **evento atteso** (imprevedibile, estraneo alla pianificazione) alla nascita come **evento pianificato** (carico di aspettative e, a volte, di senso di colpa se le cose non vanno come previsto).

In un contesto di relazioni sempre più frammentate, il figlio diventa il **nuovo principio organizzatore dei legami familiari** — un "figlio del bisogno", posto al centro della realizzazione personale.

Si passa dalla **famiglia etica** (che trasmette valori e norme) alla **famiglia affettiva** (fondata sull'amore e sul legame emotivo — Pietropolli Charmet, 2000).

«I genitori tendono a trasmettere amore più che regole e principi astratti, aspirano a farsi obbedire per amore e non per paura delle sanzioni, si piegano nei confronti del figlio nella prospettiva di intercettare quale sia la sua vera natura e indole.» — Pietropolli Charmet, 2000

4. Mutano le aspettative dei ruoli Le donne hanno aspettative sempre più elevate di un **impegno paritario e condiviso** da parte dei partner nella gestione familiare.

Il processo di accesso alla genitorialità

(Nanzer & Palacio Espasa)

Diventare genitore non è solo un fatto biologico — è un **processo psichico profondo** che inizia nell'infanzia ma si intensifica nel **periodo perinatale** (dal concepimento ai primi due anni dopo il parto).

Durante questa fase: - La donna attraversa un periodo di "**trasparenza psichica**": estrema sensibilità emotiva, riemersione del passato - Il genitore compie un **movimento regressivo** verso i propri vissuti infantili - Emergono

domande fondamentali: *"Che genitore sarò? Come erano i miei genitori? Voglio essere uguale o diverso/a?"*

Il processo implica **lutti di sviluppo**: occorre rinunciare a immagini idealizzate dei propri genitori, o elaborare perdite reali vissute nell'infanzia.

Fin qui ci siamo? Bene. Perché adesso viene la parte che, come futuro assistente sociale, tornerà più spesso nella tua pratica.

Quando questi lutti sono **ben elaborati** → la genitorialità diventa un'occasione di crescita e "riedizione corretta" delle relazioni infantili.

Quando **non lo sono** → il bambino rischia di essere inconsciamente arruolato per riparare o compensare ciò che il genitore non ha elaborato.

Come in un videogioco in cui un personaggio deve completare le quest non finite di un altro: il bambino porta il peso delle storie irrisolte dei genitori.

Anche le tappe di sviluppo del bambino (edipo, latenza, adolescenza) possono **riattivare** conflitti irrisolti nel genitore — per esempio, l'adolescenza del figlio mobilita spesso i vissuti dell'adolescenza del genitore.

I conflitti della genitorialità: quattro livelli

(da Cramer & Palacio Espasa 1993; Manzano, Palacio Espasa & Zilkha 1999)

Il meccanismo centrale è quello delle **identificazioni proiettive**: il genitore proietta sul bambino immagini di sé da bambino, o dei propri genitori. Queste proiezioni possono essere sane e flessibili, oppure rigide e deformanti.

Freud (1914) aveva già intuito che i genitori rendono i figli depositari del proprio narcisismo infantile a cui hanno dovuto rinunciare.

Livello 1 — Genitorialità "normale"

- Identificazioni proiettive **flessibili e bidirezionali** ("esternalizzanti")

- Il genitore si mette al posto del bambino e sa tornare al proprio punto di vista (empatia funzionale)
- Le immagini proiettate sono prevalentemente **positive e libidiche**
- Con il tempo queste immagini **sfumano**, lasciando spazio alla specificità del bambino reale

Esempio: "Ho avuto un'infanzia buona nel complesso. Mi arrabbio a volte coi miei genitori, ma la nostra relazione è solida. Faccio del mio meglio con mio figlio, non sono perfetto ma stiamo bene."

Livello 2 — Genitorialità nevrotica

- Il bambino viene **usato inconsciamente** per negare o riparare dolori infantili del genitore
- Il genitore proietta sul bambino un'immagine idealizzata (il bambino che lui avrebbe voluto essere)
- Si identifica con un genitore ideale: presente, disponibile, tollerante — ciò che i suoi genitori non erano stati abbastanza
- Obiettivo inconscio: "**riscrivere la storia**" infantile
- Narcisismo "antidepressivo": lo scopo è evitare i sentimenti di privazione, non attaccare il bambino
- Impatto: disturbi di separazione, sonno, alimentazione, comportamento nel bambino
- In terapia: **pre-transfert positivo** verso il terapeuta

Esempio: "La partenza di mio padre mi ha lasciato una mancanza. Voglio che mio figlio abbia l'infanzia perfetta che non ho avuto."

Livello 3 — Genitorialità masochistica

Due varianti: 1. Il genitore si è vissuto da bambino come **responsabile della tristezza/depressione dei propri genitori** 2. Il genitore ha coltivato **rivendicazioni** verso genitori vissuti come abbandonanti o indegni

Dinamica: proietta sul bambino l'immagine del bambino-difficile, identificandosi col genitore-vittima. Si **sottomette** alla tirannia del bambino come espiazione.

Impatto: disturbi del comportamento più gravi, disturbi ansiosi o dell'umore nel bambino.

In terapia: **pre-transfert positivo**, ma il terapeuta deve fare attenzione a non mostrarsi colpevolizzante (il Super-Io già spinge all'espiazione).

Esempio: "I miei genitori hanno sacrificato tutto per me, sembravano sempre tristi. Oggi mio figlio fa solo di testa sua — ho l'impressione che cerchi di farmi pagare quello che ho fatto passare ai miei genitori."

Livello 4 — Genitorialità narcisistica

Il livello più grave. Le identificazioni proiettive sono: - **Rigide, unidirezionali, evacuatrici e deformanti** - Il genitore proietta aspetti **negativi** di sé (avidità, aggressività, pericolo) sul bambino - Genera un senso di persecuzione: il bambino viene vissuto come ostile o estraneo - Difese intense: **diniego e scissione** — il genitore è tagliato dalla propria vita emotiva - Anamnesi del passato vuota: *"Un'infanzia normale, come tutte le altre..."* - **Pre-transfert negativo**: il terapeuta viene vissuto come persecutore

Impatto sul bambino: gravi disturbi dell'attaccamento, depressioni, disarmonie evolutive o psicotiche. A lungo termine: disturbo della personalità.

Esempio: "La mia infanzia? Non ho niente da dire. Oggi non capisco mio figlio — non mi ascolta, penso che non mi voglia bene."

I casi clinici: la teoria in azione

Caso Myriam — "L'erede psicologica"

(Palacio Espasa, Manzano & Zilkha — dal volume "Scenari della genitorialità")

La situazione: Myriam, 11 anni e mezzo, adottata fin da piccola. Difficoltà scolastiche gravi, tristezza, inibizione, conflitti col fratello. La madre ha scelto l'adozione specificamente per **rompere con una linea ereditaria di gravi depressioni** nella sua famiglia d'origine — ma ora vede Myriam triste.

La dinamica: - La madre proietta su Myriam l'immagine della **propria madre depressa** - Spera di recuperare il legame con la madre, "guarirla" e accedere a un'immagine migliore di sé - Il meccanismo fallisce: Myriam diventa ugualmente triste, confermando la proiezione - La bambina **si identifica istericamente** con gli aspetti depressivi proiettati — probabilmente per mantenere l'interesse della madre

L'intervento terapeutico: - Primo intervento della terapeuta: *"Penso che siate molto tristi tutte e due, e tristi che anche l'altra lo sia."* La madre piange, Myriam si avvicina a lei. - Successivamente: la madre si riappropria della propria depressione e chiede una psicoterapia per sé - A Myriam vengono proposte sedute individuali centrate sulla problematica isterica (rivalità fallica, angosce di separazione) - **Esito:** Myriam completa l'anno scolastico con successo, sviluppa nuove relazioni coi coetanei e si autonomizza

Concetto chiave: fuggendo l'eredità biologica (la depressione genetica), la madre ha costruito ugualmente un'**eredità psicologica**. Il sintomo di Myriam era il lutto irrisolto della madre travestito da tristezza della figlia.

Caso Régine — "Il sorriso di sollievo"

(Palacio Espasa, Manzano & Zilkha)

La situazione: Régine, 9 anni. Difficoltà di separazione severa: non riesce a dormire fuori casa, si angoscia quando qualcuno in famiglia perde un oggetto, pensa costantemente alla famiglia quando è lontana. La madre ha perso entrambi i genitori: il padre 12 anni prima, la madre quando era adolescente.

La dinamica: - La madre proietta su Régine l'immagine della **"buona madre" che protegge dalla perdita** — quella madre che lei non ha avuto/ha perso - Régine **si identifica con l'oggetto proiettato:** diventa la bambina che non abbandona la mamma, per non farla sentire sola - Il sintomo — l'angoscia di separazione — è in realtà il lutto della madre che la bambina porta per lei

L'intervento terapeutico: Un unico intervento, rivolto alla bambina ma destinato anche alla madre:

"Prima la mamma era molto preoccupata che tu rischiassi di essere triste, e adesso sei tu che pensi che non devi lasciare la mamma."

La madre rimane stupita. Régine **sorride sollevata**. Nella stessa seduta, le due organizzano insieme un breve soggiorno da una cugina.

Esito: in una sola consultazione, il sintomo si dissolve perché la bambina viene liberata dal peso della proiezione.

Concetto chiave: il sintomo di Régine non era suo — era il lutto irrisolto della madre che la bambina portava in nome di lei. Liberata da questo compito, Régine può finalmente essere una bambina.

Plurigenitorialità e spazio psichico del bambino

Le famiglie ricomposte, adottive e plurigenitoriali pongono sfide specifiche per il bambino:

- Le **modificazioni brusche** dell'ambiente familiare mettono in pericolo la **continuità narcisistica** del bambino
- È fondamentale **dare senso alle trasformazioni**: mettere in parole l'inatteso, aiutare il bambino a costruire una narrativa coerente della propria storia
- Ammettere la **bilinearità delle origini**: il bambino cresciuto nella certezza della propria doppia origine riesce a trovare il "terzo" accanto alla madre — ciò che dà senso alle assenze e agli "abbandoni"

Rispettare lo spazio psichico del bambino significa: - Spiegargli, in modo misurato, quello che succede - Accettare che abbia sentimenti e opinioni proprie, anche scomodi - Dargli il **diritto al segreto** - Aiutarlo a conservare buoni ricordi degli assenti - Prendere misura delle discontinuità che vive

Nuove pratiche di genitorialità e conseguenze per i bambini

(Lazartigues, 2000)

Nella famiglia contemporanea, l'**edonismo** — la ricerca di piacere immediato — ha preso il posto del dovere come valore centrale trasmesso ai figli.

Conseguenze osservate: - **Ridotta tolleranza alla frustrazione** e all'attesa - Malessere e comportamenti **auto/eteroaggressivi** o di evitamento - Difficoltà nell'integrazione del **senso morale**

Concetti chiave

Termine	Significato
Genitorialità	Insieme delle funzioni svolte dal genitore verso il figlio (biologica, nutritiva, educativa, identitaria, di accesso all'età adulta)
Plurigenitorialità	Distribuzione delle funzioni genitoriali su più figure adulte
Genitorialità biologica / istituzionale / domestica	Tre dimensioni dissociabili della genitorialità contemporanea
Seconda transizione demografica	Calo strutturale della fecondità dal dopoguerra, legato a cambiamenti valoriali
Trasparenza psichica	Stato di estrema sensibilità della donna in gravidanza: riemersione del passato infantile
Lutti di sviluppo	Rinunce psichiche necessarie per diventare genitore
Identificazioni proiettive	Meccanismo per cui il genitore proietta sul figlio immagini di sé o dei propri genitori

Termine	Significato
Genitorialità nevrotica	Bambino usato per riparare dolori infantili irrisolti — proiezioni empatiche ma vincolanti
Genitorialità masochistica	Il genitore si sottomette al bambino per espiare sensi di colpa del passato
Genitorialità narcisistica	Proiezioni rigide e deformanti; pre-transfert negativo; gravi conseguenze per il bambino
Pre-transfert	Atteggiamento iniziale del genitore verso il terapeuta, influenzato dalle proiezioni sulle figure d'autorità
Famiglia affettiva	Modello post-moderno fondato sull'amore e sulla realizzazione emotiva (vs. famiglia etica, basata sulla trasmissione di valori normativi)
Bilinearità delle origini	Riconoscimento delle due linee di provenienza del bambino, fondamentale nelle famiglie ricomposte/adottive

Domande di orientamento allo studio

Perché non esiste una definizione universale di famiglia e quali sono le principali tipologie contemporanee? Non esiste una definizione universale perché il concetto di famiglia è storicamente, culturalmente e socialmente determinato. Ciò che viene considerato "famiglia" cambia nel tempo e tra culture diverse. Le principali tipologie contemporanee includono: nucleare, monoparentale, ricomposta, omo-genitoriale, d'affido, adottiva, da procreazione assistita, di genitori separati, unipersonale, LAT (Living Apart Together) e DINKS (Double Income, No Kids). I sociologi oggi parlano di "famiglie" al plurale, sottolineando che un individuo può attraversare più forme familiari nel corso della vita.

Cosa sono le cinque funzioni della genitorialità secondo Esther Goody e come si dissociano nella contemporaneità? Goody (1976, 1999) ha

scomposto la genitorialità in cinque funzioni: concepire e mettere al mondo, nutrire, educare, dare un'identità alla nascita, garantire l'accesso allo statuto di adulto. Nelle società occidentali queste funzioni tendono a concentrarsi sugli stessi genitori biologici, ma in molte culture non occidentali vengono distribuite tra più adulti. Nella contemporaneità questa dissociazione si manifesta tra genitorialità biologica (chi concepisce), istituzionale/giuridica (chi ha il riconoscimento legale) e domestica (chi si occupa della cura quotidiana).

Quali sono i quattro livelli di conflitto della genitorialità secondo

Cramer, Palacio Espasa e collaboratori? I quattro livelli sono: 1) Genitorialità "normale" — identificazioni proiettive flessibili e bidirezionali, prevalentemente positive, che lasciano spazio alla specificità del bambino reale. 2) Genitorialità nevrotica — il bambino viene usato inconsciamente per negare o riparare dolori infantili del genitore; il bambino rappresenta l'infanzia idealizzata che il genitore vorrebbe aver avuto. 3) Genitorialità masochistica — il genitore si sottomette alla tirannia del bambino come espiazione di sensi di colpa; proietta sul bambino l'immagine del bambino-difficile. 4) Genitorialità narcisistica — il livello più grave: proiezioni rigide, unidirezionali e deformanti; il bambino viene vissuto come ostile; conseguenze gravi per lo sviluppo del bambino.

Cosa si intende per "trasparenza psichica" nel processo di accesso alla genitorialità? La trasparenza psichica è uno stato di estrema sensibilità emotiva che la donna attraversa in gravidanza: c'è una riemersione del passato infantile, emergono domande fondamentali su cosa significa diventare genitore, e il genitore compie un movimento regressivo verso i propri vissuti infantili. Questo processo implica dei "lutti di sviluppo": la rinuncia alle immagini idealizzate dei propri genitori. Quando questi lutti vengono ben elaborati, la genitorialità diventa un'opportunità di crescita. Quando non lo sono, il bambino rischia di essere arruolato inconsciamente per riparare ciò che il genitore non ha risolto.

Cosa si intende per "rispettare lo spazio psichico del bambino" nelle famiglie ricomposte o plurigenitoriali? Rispettare lo spazio psichico del bambino significa: spiegargli, in modo misurato e adeguato alla sua età, quello che succede nelle trasformazioni familiari; accettare che abbia sentimenti e opinioni proprie, anche scomodi; dargli il diritto al segreto; aiutarlo a conservare buoni ricordi degli assenti; prendere misura delle discontinuità che vive. È fondamentale

ammettere la bilinearità delle origini — il bambino cresciuto nella certezza della propria doppia provenienza riesce meglio a trovare un senso alle assenze e agli "abbandoni".

Collegamenti

- **Lezione 01 (ciclo di vita):** la genitorialità come transizione identitaria — uno dei momenti di crisi/sviluppo del ciclo vitale
- **Lezione 04 (coppia):** la coppia come sistema che precede la genitorialità; le sue dinamiche influenzano il processo genitoriale
- **Da approfondire:** psicoterapia madre-bambino (Cramer & Palacio Espasa 1993); teoria dell'attaccamento (Bowlby); "fantasmi nella nursery" (Fraiberg et al.)